REKAM MEDIS ELEKTRONIK

PANDUAN PENGGUNAAN

Modul Rawat Jalan

Tim Pengembang RME
RSD dr. Soebandi Jember

DAFTAR ISI

1. Rekam Medis Elektronik (RME) 3
2. Hak Akses User dan Kamus Ikon 3
4. Dashboard Sistem 4
5. Pencarian Pasien (Rawat Jalan) 4
6. Dashboard Rawat Jalan 5
7. Formulir Rekam Medis Rawat Jalan 6
7.1 Pengkajian Awal Rawat Jalan RM 02.1 6
7.1.1 Pengkajian Keperawatan 7
7.1.2 Pengkajian Medis 12
7.1.3 Arsip 15
7.2 Resume Medis Rawat Jalan 15
7.3 E-Resep 16
8. Petunjuk Operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Dan Rekam Medis Elektronik 17
9. Penatalaksanaan Downtime Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Dan Rekam Medis Elektronik 18

RSD
dr.SOEBANDI

PANDUAN PENGGUNAAN
REKAM MEDIS ELEKTRONIK MODUL RAJAL

1. Rekam Medis Elektronik (RME)

Menurut permenkes no 24 tahun 2022 Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis. Rekam Medis Elektronik (RME) wajib diselenggarakan oleh seluruh fasilitas layanan kesehatan dan diberikan waktu transisi paling lambat 31 Desember 2023.

Kewajiban penyelenggaraan RME oleh Fasyankes termasuk layanan telemedisin oleh Fasyankes. Seluruh Fasyankes wajib memiliki sistem elektronik dan menyelenggarakan RME wajib mengikuti standar variable dan metadata meliputi definisi, format, dan kodifikasi termasuk protokol pertukaran data yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Pasien berhak mendapatkan isi rekam medis miliknya dan memberikan akses atas persetujuan pasien. Fasyankes rujukan memiliki hak akses terhadap isi rekam medis elektronik seorang pasien atas persetujuan pasien. Fasyankes wajib terhubung melalui platform terintegrasi dan ber interoperabilitas (SATUSEHAT) yang telah disediakan oleh Kementerian Kesehatan.

Aspek hukum rekam rekam medis elektronik diatur dalam UU ITE No 11 tahun 2008 Pasal 5, PP SIK No 46 Tahun 2014 pasal 17 dan KMK No HK/01.07/Menkes/1423/2022 tentang Pedoman Variabel dan Meta Data Pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik. Dasar pembuatan rekam medis elektronik di RSD dr. soebandi adalah KMK No HK/01.07/Menkes/1423/2022 dan formulir yang berjalan saat ini sesuai standar akreditasi yang berlaku.

2. Hak Akses User dan Kamus Ikon

Rekam medis elektronik memiliki menu-menu yang dapat diakses oleh setiap level user. Berikut adalah hak akses user terhadap menu yang tersedia di Rawat Jalan.

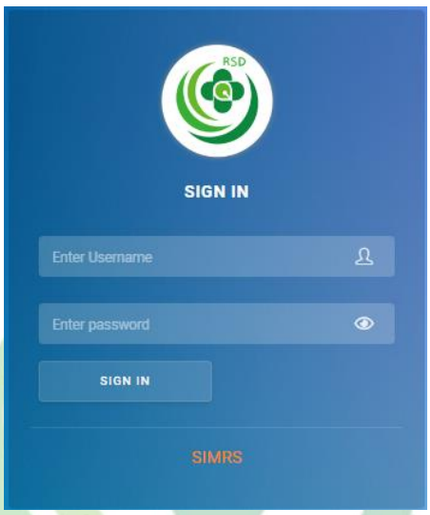
No.	Menu	User		
		Tenaga Medis	Perawat/Bidan	Bidan
1	Riwayat Pasien	✓	✓	✓
2	Riwayat RME	✓	✓	✓
3	RM 02.1- Pengkajian Awal Rawat Jalan			
	Pengkajian Keperawatan		✓	
	Pengkajian Medis	✓		
	Arsip	✓	✓	✓
4	RM 05.11.1 - Resume Medis Rawat Jalan	✓	✓	✓
5	RM 09.3 – E-Resep	✓		

Icon	Deskripsi
	Edit data yang telah disimpan
	Hapus data yang telah disimpan

	Menyalin/menduplikasi sesuai baris yang dipilih untuk menjadi inputan baru
	Mencetak dokumen

3. Masuk ke Sistem (Sign In)

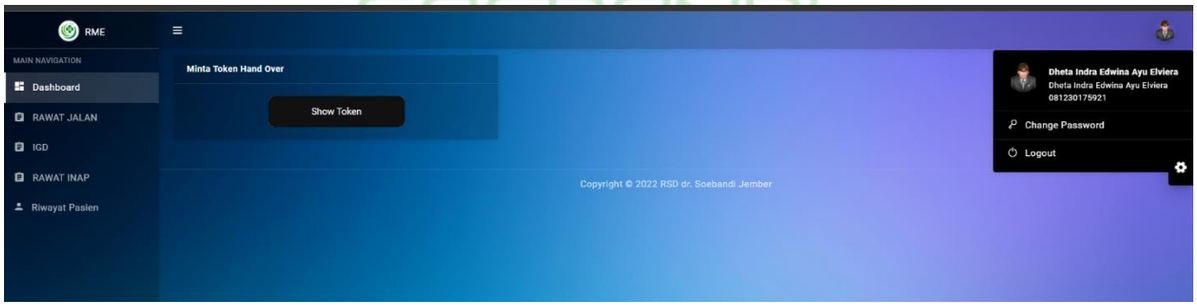
Klik pemintas RME yang sudah tersedia di komputer ruangan. Masukkan *username* dan *password* yang dimiliki oleh user. Setelah itu, klik **Sign In**.



Gambar 1. Halaman Sign In RME RSD dr. Soebandi

4. Dashboard Sistem

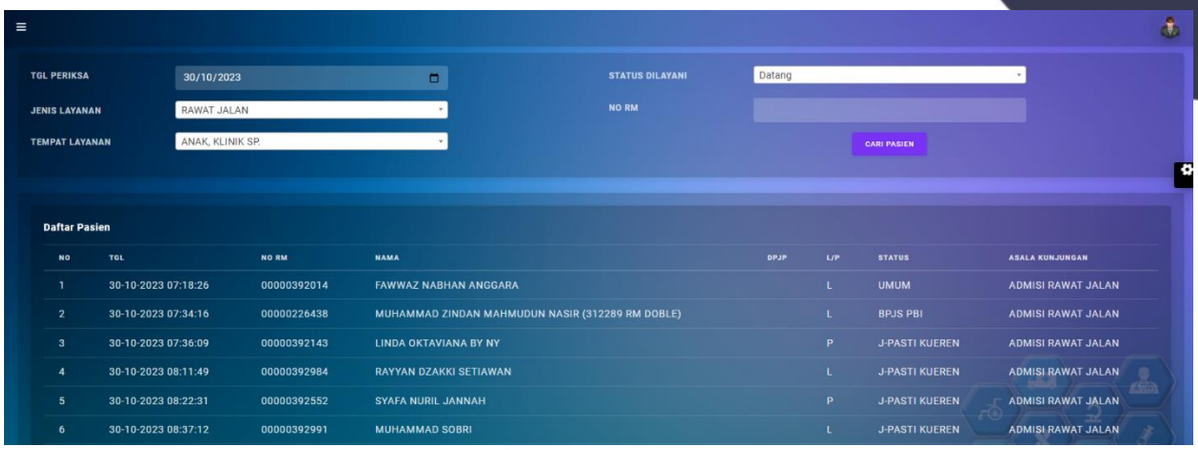
Setelah berhasil *sign in*, user akan masuk ke halaman awal. Pada halaman awal, user dapat memilih lokasi pasien yang akan dimasukkan data rekam medisnya (Rawat Jalan atau Rawat Inap). Pada ikon orang di sebelah kanan atas, user juga dapat melakukan pergantian password dan keluar dari sistem (*Log Out*).



Gambar 2. Halaman Awal Sistem

5. Pencarian Pasien (Rawat Jalan)

Setelah user memilik unit, user dapat melakukan pencarian data pasien. User dapat melakukan pencarian menggunakan tanggal periksa, tempat layanan (poli klinik), status dilayani (pasien datang dan pasien pulang, dan nomor rekam medis. Setelah memilih atau memasukkan instrument pencarian, user dapat klik tombol Cari Pasien.



Gambar 3. Halaman Pencarian Pasien

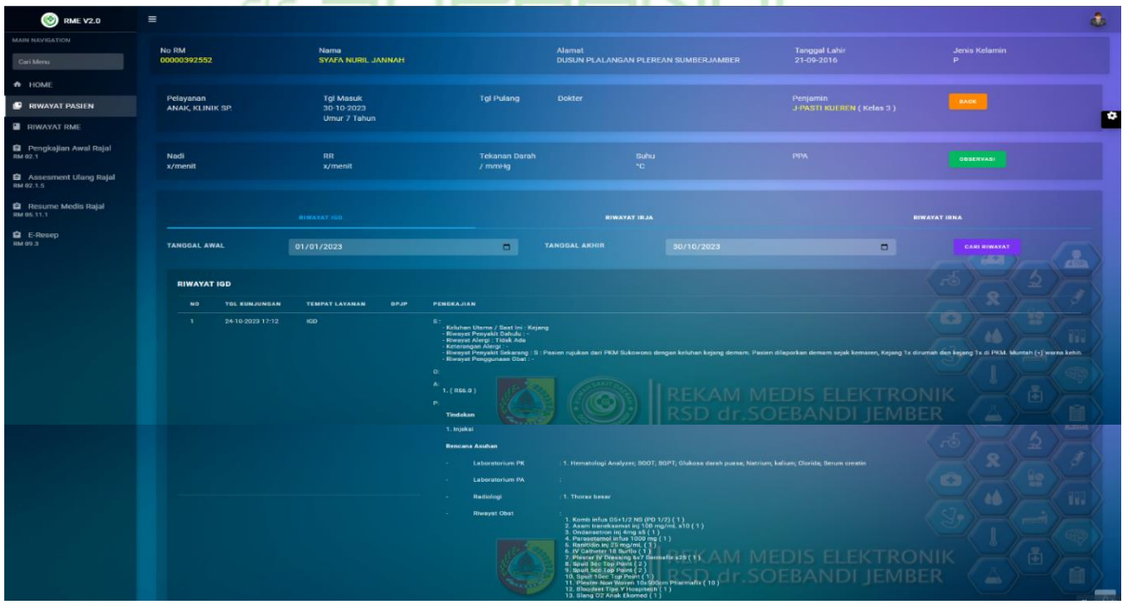
Terdapat informasi jam kunjung, nomor rekam medis, nama pasien, DPJP, jenis kelamin, status pembayaran, dan asal kunjungan. Daftar pasien yang ditampilkan berdasarkan jam kunjung yang paling awal. Untuk mengisi data rekam medis pasien, user dapat mengklik nama pasien.

6. Dashboard Rawat Jalan

Pada halaman ini, user telah masuk ke *dashboard* pasien. Terdapat informasi pasien yang mencakup Nomor Rekam Medis, Nama, Alamat, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Tempat Layanan, Tanggal Masuk, Tanggal Pulang, DPJP, dan Penjamin. User juga dapat mengetahui data *vital sign* pasien apabila data telah terisi.

User dapat melihat riwayat pemeriksaan pasien (Menu **Riwayat Pasien**) yang ditampilkan dengan format SOAP, berdasarkan unit pelayanan (IGD, Rawat Jalan, dan Rawat Inap). Masing-masing dapat dilakukan pencarian berdasarkan periode tanggal yang diinginkan.

Pada sisi sebelah kiri terdapat daftar formulir rekam medis yang perlu diisi terkait kunjungan pasien.



Gambar 4. Dashboard Pasien Rawat Jalan

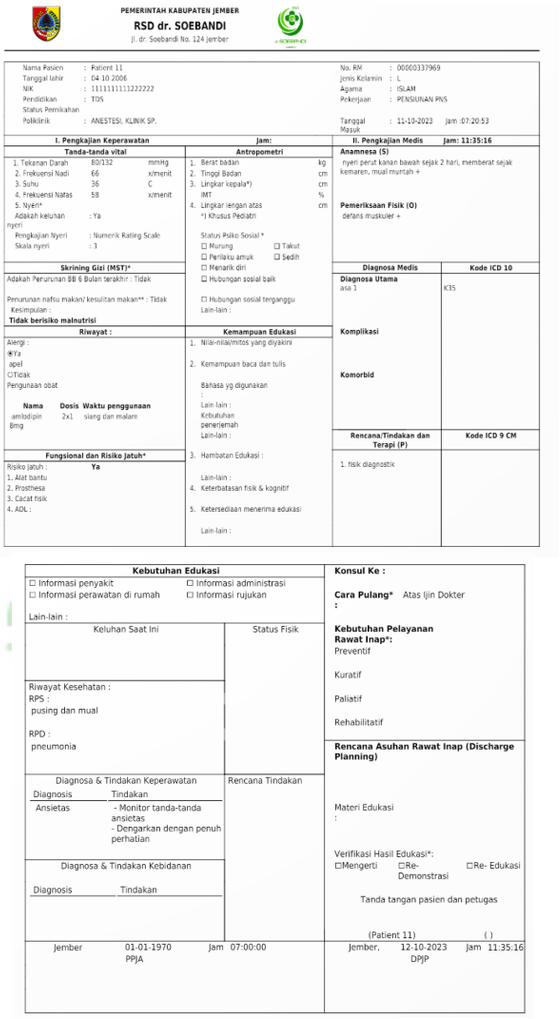
7. Formulir Rekam Medis Rawat Jalan

7.1 Pengkajian Awal Rawat Jalan RM 02.1

Formulir Pengkajian Awal Rawat Jalan adalah formulir yang harus diisi oleh semua user (dokter dan perawat/bidan). Instrumen yang terdapat di dalam formulir telah disesuaikan dengan meta data yang dibutuhkan oleh Kemenkes dan data yang dibutuhkan oleh rumah sakit terkait akreditasi. Formulir rekam medis elektronik yang terisi dapat dicetak dengan format seperti gambar berikut.

Pada formulir ini terbagi menjadi 3 submenu yang akan ditampilkan berdasarkan level user:

- **User sebagai Dokter** akan hanya dapat melihat **Subemnu Pengkajian Medis** dan **Arsip.**
- **User sebagai Perawat/Bidan** akan hanya dapat melihat **Submenu Pengkajian Keperawatan** dan **Arsip.**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
RSD dr. SOEBANDI
Jl. dr. Soebandi No. 124 Jember

Nama Pasien : Patient 11
Tanggal lahir : 04-10-2006
NIK : 1111111111222222
Pendidikan : TDS
Status Pernikahan :
Poliklinik : ANESTESI, KLINIK SP.

No. RM : 00000337969
Jenis Kelamin : L
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PENSIUNAN PNS
Tanggal Masuk : 11-10-2023 Jam :07:20:53

I. Pengkajian Keperawatan — **Jam:**

Tanda-tanda vital

1. Tekanan Darah	80/132	mmHg
2. Frekuensi Nadi	66	x/menit
3. Suhu	36	C
4. Frekuensi Natas	58	x/menit
5. Nyeri*		
Adakah keluhan nyeri	: Ya	
Pengkajian Nyeri	: Numerik Rating Scale	
Skala nyeri	: 3	

Antropometri

1. Berat badan		kg
2. Tinggi Badan		cm
3. Lingkar kepala*)		cm
IMT		%
4. Lingkar lengan atas		cm

*) Khusus Pediatri

Status Psiko Sosial *
☐ Murung ☐ Takut
☐ Perilaku amuk ☐ Sedih
☐ Menarik diri
☐ Hubungan sosial baik
☐ Hubungan sosial terganggu
Lain-lain :

Skrining Gizi (MST)*
Adakah Penurunan BB 6 Bulan terakhir : Tidak
Penurunan nafsu makan/ kesulitan makan** : Tidak
Kesimpulan :
Tidak berisiko malnutrisi

Riwayat :
Alergi :
◉Ya
apel
○Tidak
Pengunaan obat

Nama	Dosis	Waktu penggunaan
amlodipin 8mg	2x1	siang dan malam

Kemampuan Edukasi
1. Nilai-nilai/mitos yang diyakini
2. Kemampuan baca dan tulis
Bahasa yg digunakan :
Lain-lain :
Kebutuhan penerjemah
Lain-lain :
3. Hambatan Edukasi :
Lain-lain :
4. Keterbatasan fisik & kognitif
5. Ketersediaan menerima edukasi
Lain-lain :

Fungsional dan Risiko Jatuh*
Risiko Jatuh : **Ya**
1. Alat bantu
2. Prosthesa
3. Cacat fisik
4. ADL :

II. Pengkajian Medis — **Jam: 11:35:16**

Anamnesa (S)
nyeri perut kanan bawah sejak 2 hari, memberat sejak kemaren, mual muntah +

Pemeriksaan Fisik (O)
defans muskuler +

Diagnosa Medis	Kode ICD 10
Diagnosa Utama asa 1	K35
Komplikasi	
Komorbid	
Rencana/Tindakan dan Terapi (P)	**Kode ICD 9 CM**
1. fisik diagnostik	

Kebutuhan Edukasi
☐ Informasi penyakit ☐ Informasi administrasi
☐ Informasi perawatan di rumah ☐ Informasi rujukan
Lain-lain :

Konsul Ke :

Cara Pulang* Atas Ijin Dokter
:

Kebutuhan Pelayanan Rawat Inap*:
Preventif
Kuratif
Paliatif
Rehabilitatif

Keluhan Saat Ini	Status Fisik
Riwayat Kesehatan : RPS : pusing dan mual RPD : pneumonia	

Rencana Asuhan Rawat Inap (Discharge Planning)

Diagnosa & Tindakan Keperawatan		Rencana Tindakan
Diagnosis	Tindakan	
Ansietas	- Monitor tanda-tanda ansietas - Dengarkan dengan penuh perhatian	

Diagnosa & Tindakan Kebidanan	
Diagnosis	Tindakan

Materi Edukasi
:

Verifikasi Hasil Edukasi*:
☐Mengerti ☐Re-Demonstrasi ☐Re- Edukasi

Tanda tangan pasien dan petugas

(Patient 11) ( )

Jember 01-01-1970 Jam 07:00:00
PPJA

Jember, 12-10-2023 Jam 11:35:16
DPJP

Gambar 5. Hasil Cetak Formulir Pengkajian Awal Rawat Jalan

7.1.1 Pengkajian Keperawatan

a. Vital Sign: perawat/bidan mengisi bagian *Vital Sign* pasien. Sebelum mengklik bagian lain, perawat/bidan perlu klik tombol Simpan terlebih dahulu.



Gambar 66. Bagian *Vital Sign*

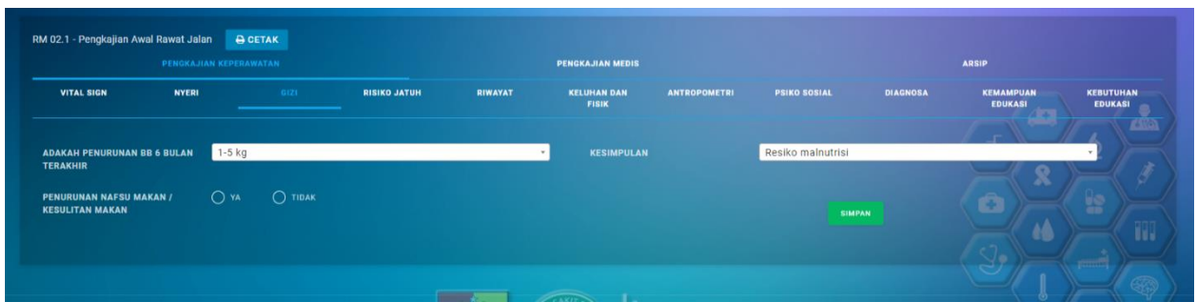
b. Nyeri*:* perawat/bidan mengisi status nyeri pasien. Skala nyeri akan muncul berdasarkan jenis pengukuran yang diklik/dipilih. Sebelum mengklik bagian lain, perawat/bidan perlu klik tombol Simpan terlebih dahulu.



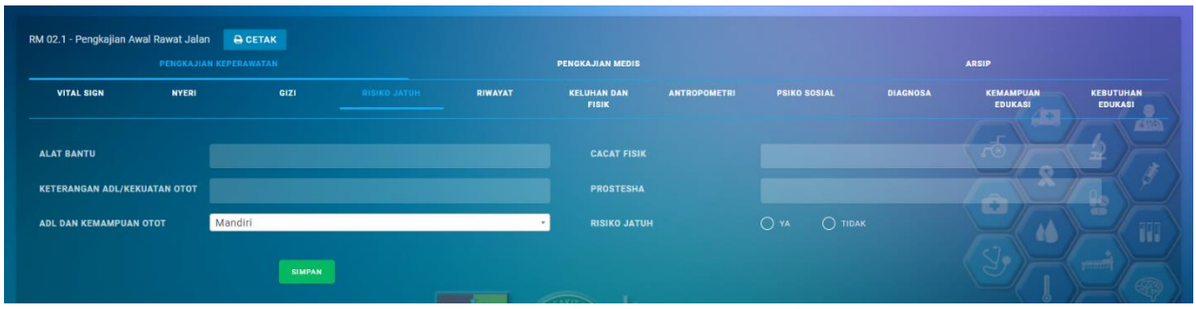
Gambar 7. Bagian Nyeri

c. Gizi: perawat/bidan mengisi status gizi pasien. Sebelum mengklik bagian lain, perawat/bidan perlu klik tombol Simpan terlebih dahulu.

Gambar 8. Bagian Gizi



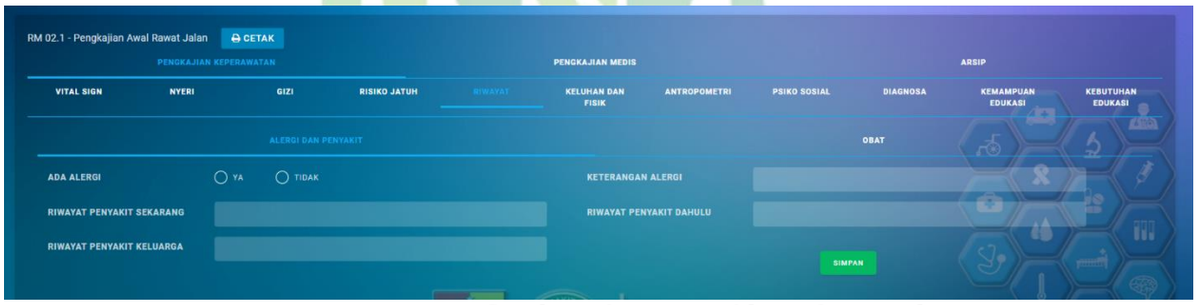
d. Risiko Jatuh: perawat/bidan mengisi status risiko jatu pasien. Apabila status risiko jatuh diisi dengan "Ya", akan tampil *alert* di dashboard pasien bahwa pasien memiliki risiko jatuh. Sebelum mengklik bagian lain, perawat/bidan perlu klik tombol Simpan terlebih dahulu.



Gambar 9. Bagian Risiko Jatuh

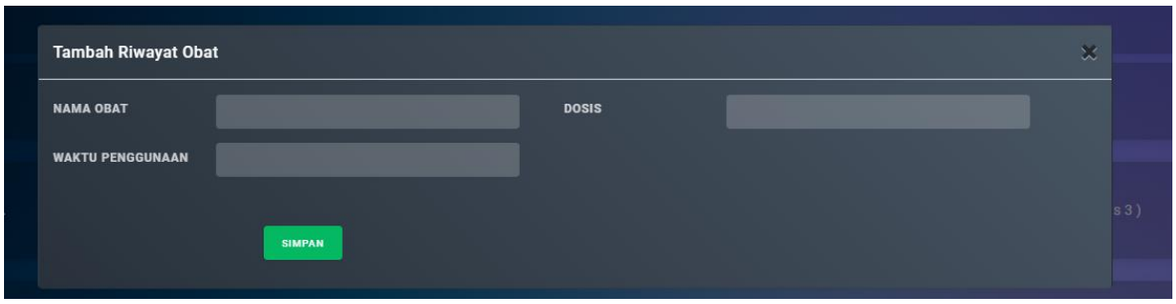
e. Riwayat: perawat/bidan mengisi riwayat alergi, penyakit, dan obat pasien. Riwayat dibagi menjadi dua bagian:

- **Riwayat Alergi & Penyakit***:* perawat/bidan mengisi riwayat alergi dan penyakut pasien. Sebelum mengklik bagian lain, perawat/bidan perlu klik tombol Simpan terlebih dahulu.



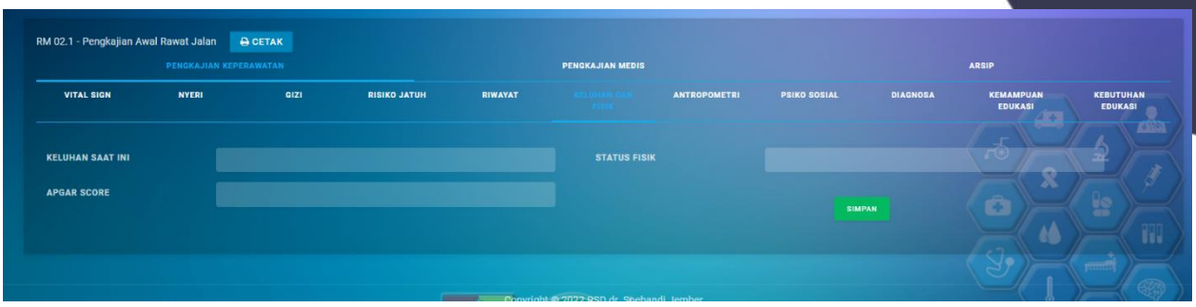
Gambar 10. Bagian Alergi & Penyakit

- **Riwayat Obat**: perawat/bidan mengisi riwayat obat dengan cara mengklik Add Riwayat Obat dan memasukkan keterangan riwayatnya. Sebelum mengklik bagian lain, perawat/bidan perlu klik tombol Simpan terlebih dahulu.



Gambar 11. Menambahkan Riwayat Obat Pasien

f. Keluhan dan Fisik: perawat/bidan mengisi keluhan dan status fisik pasien. Sebelum mengklik bagian lain, perawat/bidan perlu klik tombol Simpan terlebih dahulu.



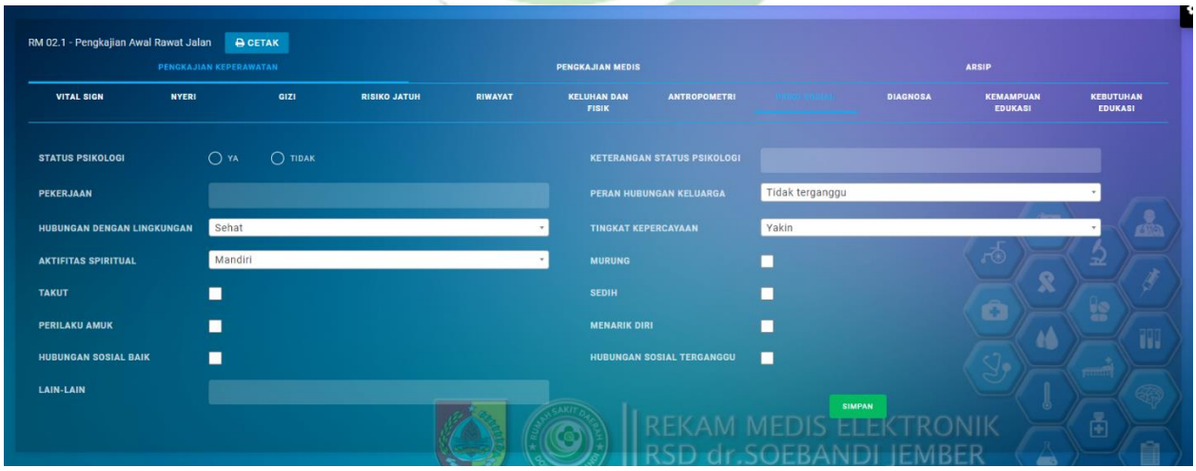
Gambar 12. Bagian Keluhan dan Fisik

g. Antropometri: perawat/bidan mengisi Antropometri pasien. Sebelum mengklik bagian lain, perawat/bidan perlu klik tombol Simpan terlebih dahulu.



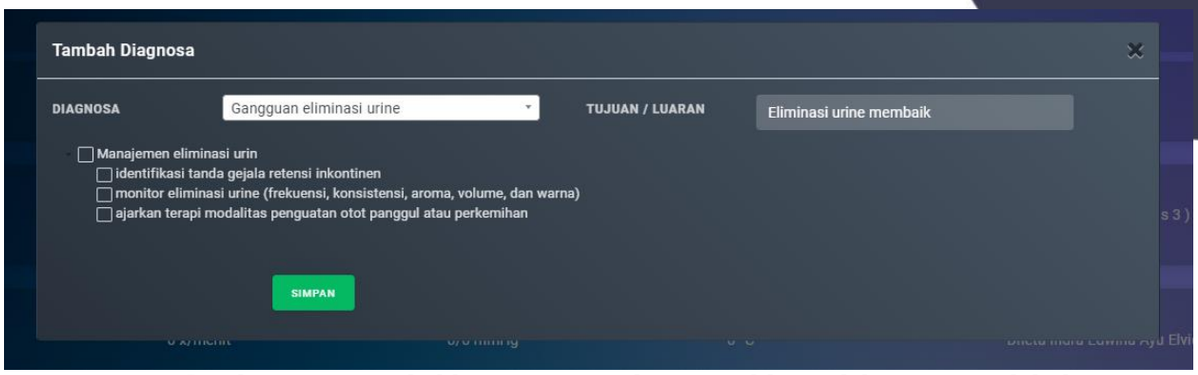
Gambar 13. Bagian Antropometri

h. Psikososial: perawat/bidan mengisi status psikososial pasien. Sebelum mengklik bagian lain, perawat/bidan perlu klik tombol Simpan terlebih dahulu.



Gambar 14. Bagian Status Psikososial Pasien

i. Diagnosa dalan Pengkajian Keperawatan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu **Diagnosa Keperawatan, Diagnosa Kebidanan**, dan **Rencana Tindakan**. Perawat/Bidan mengisi diagnosa keperawatan pasien. Perawat/bidan dapat mengklik Add Diagnosa, kemudian dapat mencari diagnosa yang sudah tersedia. Perawat/bidan dapat memberi ceklis/centang pada tindakan yang sudah dilakukan kepada pasien, kemudian klik tombol Simpan.



Gambar 7. Menambahkan Diganosa dan Memilih Tindakan yang Dilakukan kepada Pasien



Gambar 16. Bagian Diagnosa Keperawatan dan Kebidanan

User dapat melakukan edit, menduplikat, atau menghapus diagnosa dan tindakan yang sudah tersimpan. Ikon berwarna **ungu** untuk edit, ikon berwarna **oranye** untuk menghapus, dan ikon berwarna **hijau** untuk menduplikat data.



Gambar 17. Tampilan Diagnosa dan Tindakan yang Sudah Tersimpan

j. Rencana Tindakan: perawat/bidan mengisi rencana tindakan yang dilakukan kepada pasien. Sebelum mengklik bagian lain, perawat/bidan perlu klik tombol Simpan terlebih dahulu.



Gambar 18. Bagian Rencana Tindakan

k. Kemampuan Edukasi: perawat/bidan mengisi kemampuan edukasi pasien. Sebelum mengklik bagian lain, perawat/bidan perlu klik tombol Simpan terlebih dahulu.



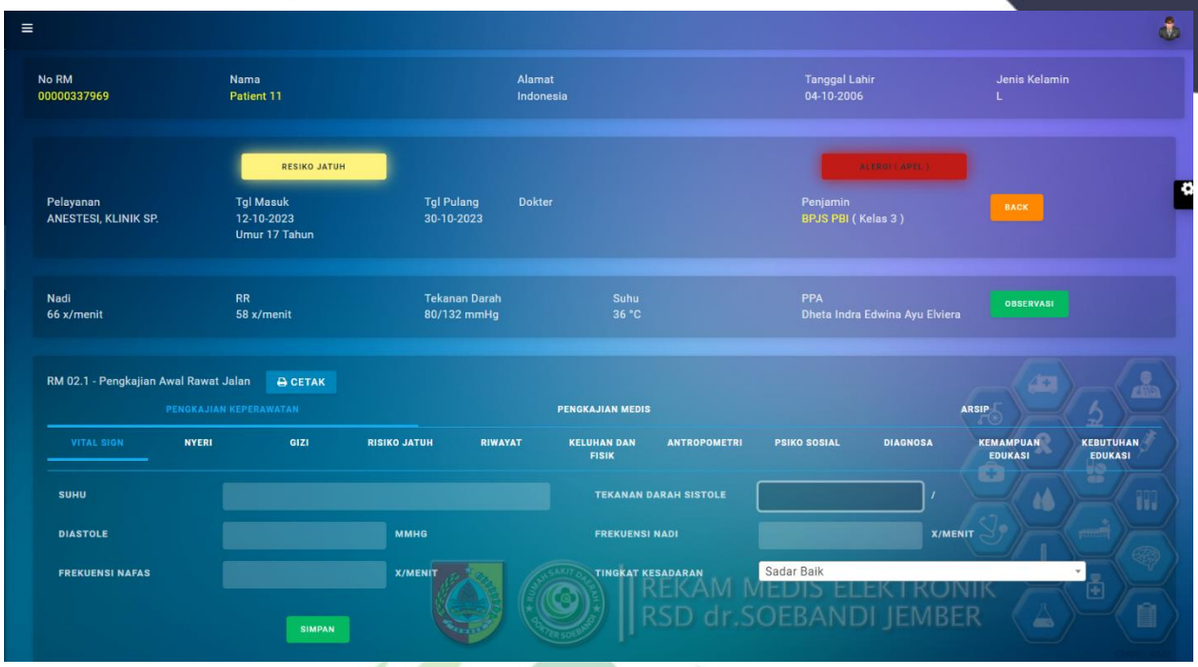
Gambar 19. Bagian Kemampuan Edukasi

l. Kebutuhan Edukasi: perawat/bidan mengisi kebutuhan edukasi pasien. Sebelum mengklik bagian lain, perawat/bidan perlu klik tombol Simpan terlebih dahulu.



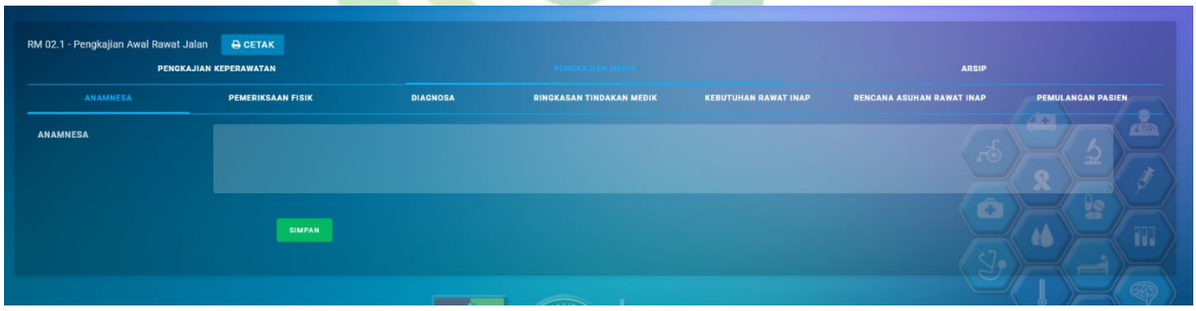
Gambar 8. Bagian Kebutuhan Edukasi

7.1.2 Pengkajian Medis

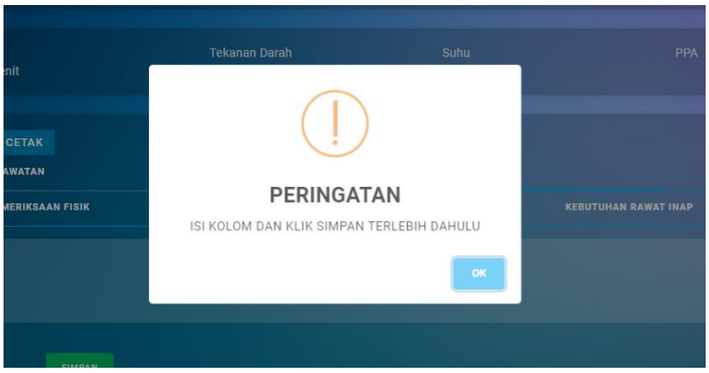


Gambar 21. Halaman Awal dari Formulir Pengkajian Rawat Jalan

a. Anamnesa : dokter mengisi anamnesa pasien. Bagian Anamnesa pasien harus terisi. Jika tidak terisi, maka dokter tidak dapat mengisi data yang lainnya. Setelah mengisi kolom, dokter harus mengklik Simpan terlebih dahulu.

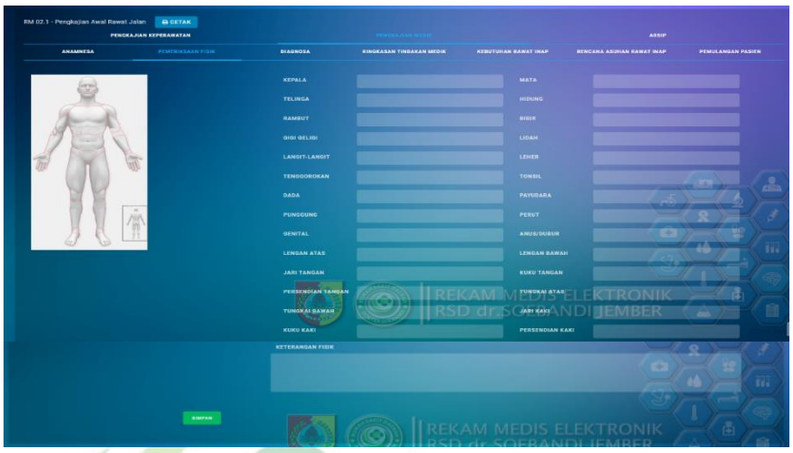


Gambar 21. Bagian Anamnesa



Gambar 22. Peringatan apabila user tidak mengisii atau tidak mengklik tombol Simpan ketika mencoba pindah ke bagian lain

b. Pemeriksaan Fisik: dokter mengisi hasil pemeriksaan pasien. Terdapat beberapa kolom dari *breakdown* anatomi tubuh yang dapat diisi dan keterangan fisik (O). Bagian Pemeriksaan Fisik pasien harus terisi. Jika tidak terisi, maka dokter tidak dapat mengisi data yang lainnya. Setelah mengisi kolom, dokter harus mengklik Simpan terlebih dahulu.



Gambar 23. Bagian Pemeriksaan Fisik

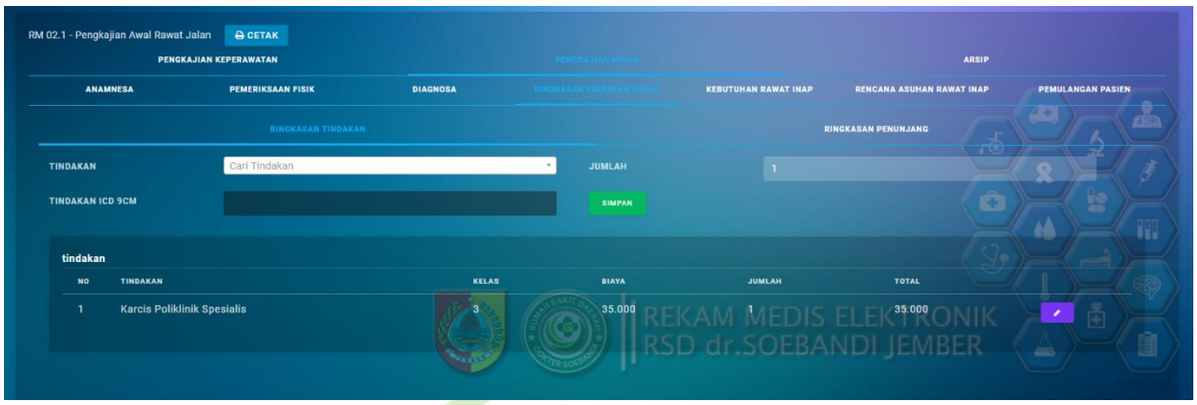
c. Diagnosa*:* dokter mengisi hasil diagnosa pasien. Terdapat beberapa kolom yang pelu diisi, yaitu Diagnosa ICD X, Status Diagnosa, Diagnosa (isian bebas), Jenis Diagnosa, Status Kasus. **Apabila dokter tidak mengetahui Diagnosa ICD X dari diagnosa pasien, dokter cukup memasukkan diagnosa (isian bebas), status diagnosa, jenis diagnosa, dan status kasus saja.** Bagian Diagnosa pasien harus terisi. Jika tidak terisi, maka dokter tidak dapat mengisi data yang lainnya. Setelah mengisi kolom, dokter harus mengklik Simpan terlebih dahulu.



Gambar 24. Bagian Diagnosa

d. Ringkasan Tindakan Medik

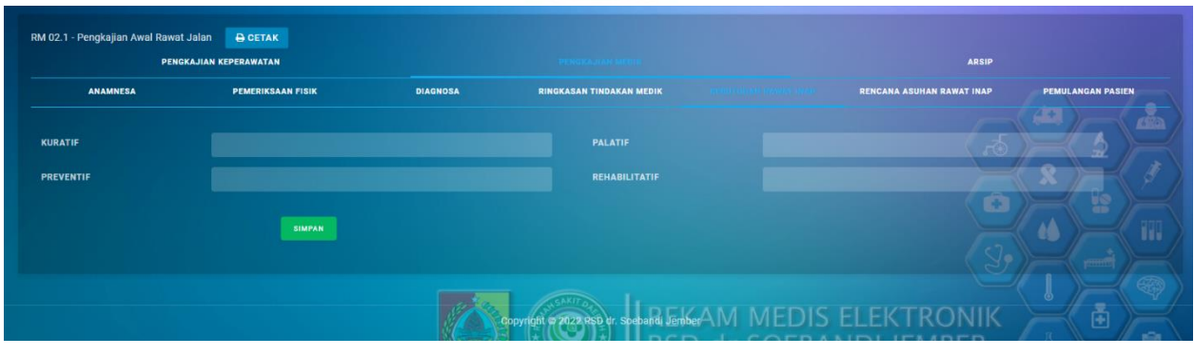
- **Ringkasan Tindakan**: dokter mengisi tindakan yang dilakukan kepada pasien pada saat kunjungan. Untuk mengisi tindakan, dokter bisa mengetikkan nama tindakan di kolom Tindakan dan memilih nama tindakan yang tersedia. Sebelum mengklik bagian lain, dokter perlu klik tombol Simpan terlebih dahulu.



Gambar 25. Bagian Ringkasan Tindakan Medik

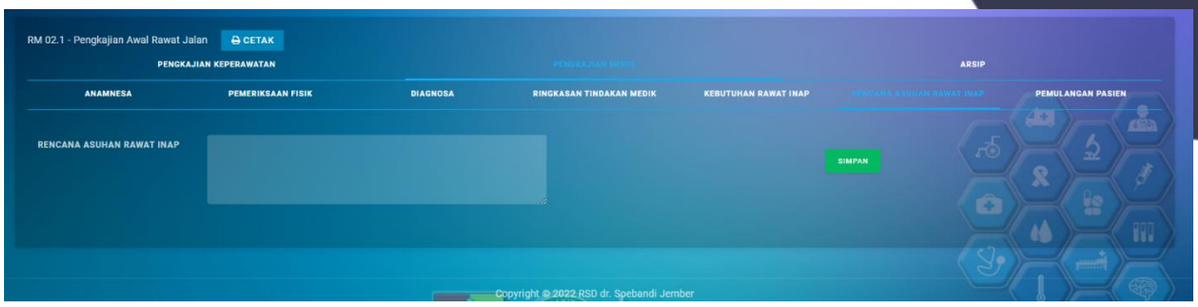
- **Ringkasan Penunjang**: dokter mengisi penunjang yang dilakukan kepada pasien pada saat kunjungan. Untuk mengisi ringkasan penunjang, dokter bisa mengetikkan nama pemeriksaan penunjang misalnya “darah lengkap, thorax foto, ecg” dan lain sebagainya. Sebelum mengklik bagian lain, dokter perlu klik tombol Simpan terlebih dahulu.

e. Kebutuhan Rawat Inap: dokter mengisi kebutuhan rawat inap apabila pasien disarankan untuk melakukan rawat inap. Sebelum mengklik bagian lain, dokter perlu klik tombol Simpan terlebih dahulu.



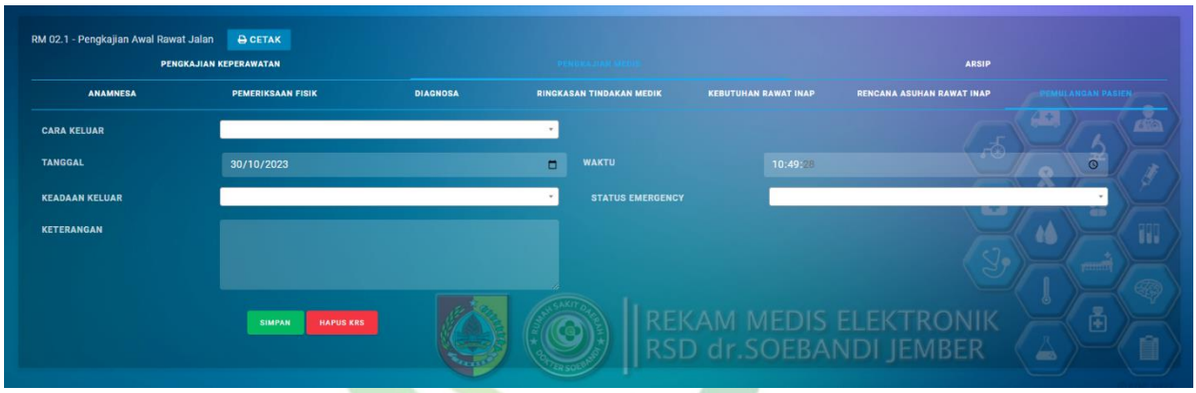
Gambar 26. Bagian Kebutuhan Rawat Inap

f. Rencana Asuhan Rawat Inap: dokter mengisi rencana asuhan rawat inap apabila pasien disarankan untuk melakukan rawat inap. Sebelum mengklik bagian lain, dokter perlu klik tombol Simpan terlebih dahulu.



Gambar 27. Bagian Rencana Asuhan Rawat Inap

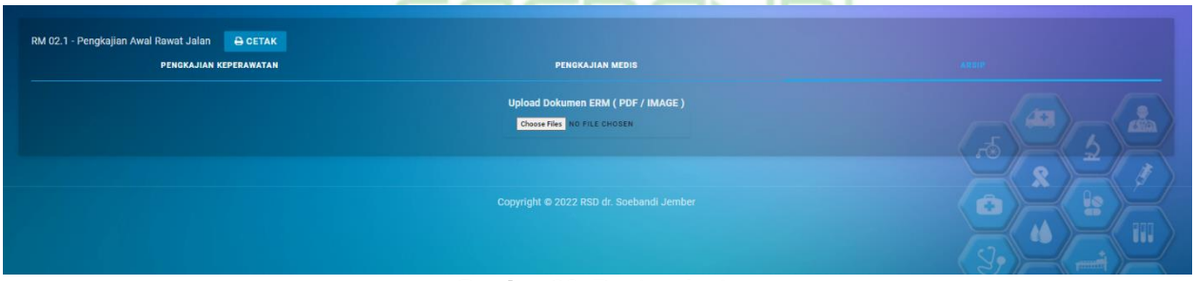
g. Pemulangan Pasien: dokter mengisi bagian Pemulangan Pasien ketika pasien selesai diperiksa. Terdapat beberapa kolom yang diisi seperti Cara Keluar, Keadaan Keluar, Status Emergency, dan Keterangan. Sebelum mengklik bagian lain, dokter perlu klik tombol Simpan terlebih dahulu.



Gambar 28. Bagian Pemulangan Pasien

7.1.3 Arsip

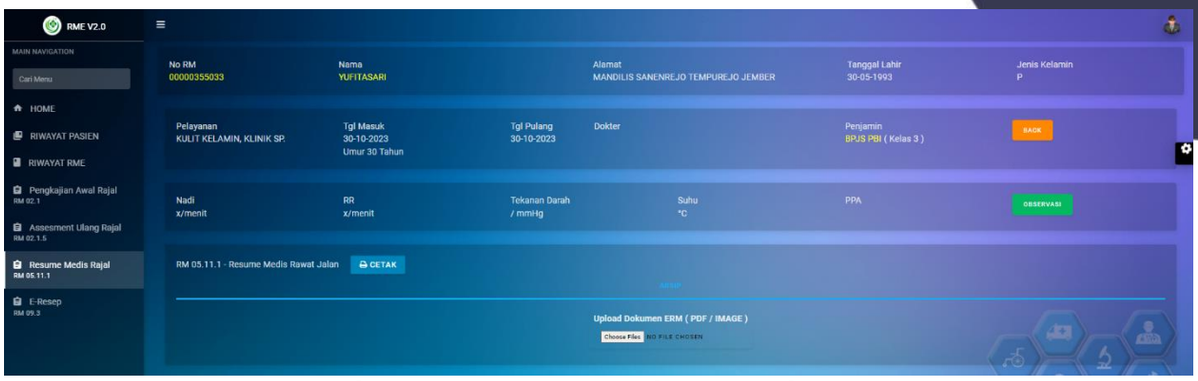
ada bagian ini, user dapat menunggah (*upload*) gambar atau informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan pasien dalam format foto (.jpg atau .jpeg) atau dokumen (.pdf)



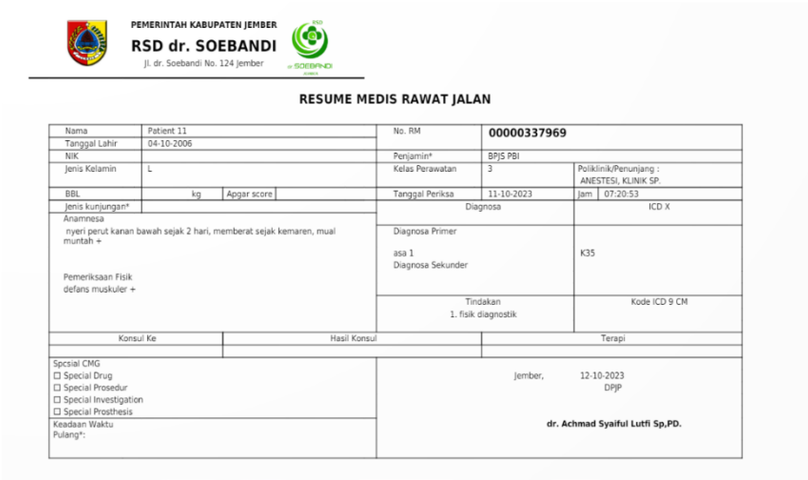
Gambar 29. Bagian Arsip

7.2 Resume Medis Rawat Jalan

Pada menu ini user dapat mencetak Resume Medis Rawat Jalan. Isi dari resume medis rawat jalan adalah yang data yang diisikan pada Formulir Pengkajian Awal Rawat Jalan.



Gambar 30. Menu Resume Medis Rawat Jalan



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
RSD dr. SOEBANDI
Jl. dr. Soebandi No. 124 Jember

RESUME MEDIS RAWAT JALAN

Nama	Patient 11	No. RM	**00000337969**
Tanggal Lahir	04-10-2006		
NIK		Penjamin*	BPJS PBI
Jenis Kelamin	L	Kelas Perawatan	3
		Poliklinik/Penunjang :	ANESTESI, KLINIK SP.
BBL	kg Apgar score	Tanggal Periksa	11-10-2023 Jam 07:20:53
Jenis kunjungan*		Diagnosa	ICD X
Anamnesa: nyeri perut kanan bawah sejak 2 hari, memberat sejak kemaren, mual muntah +		Diagnosa Primer: asa 1 Diagnosa Sekunder	K35
Pemeriksaan Fisik: defans muskuler +		Tindakan: 1. fisik diagnostik	Kode ICD 9 CM
Konsul Ke	Hasil Konsul	Terapi	
Spcsial CMG ☐ Special Drug ☐ Special Prosedur ☐ Special Investigation ☐ Special Prosthesis		Jember, 12-10-2023 DPJP **dr. Achmad Syaiful Lutfi Sp,PD.**	
Keadaan Waktu Pulang*:			

Gambar 9. Hasil Cetak Resume Medis Rawat Jalan

7.3 E-Resep

Pada menu ini, user dapat memasukkan resep obat untuk pasien yang nantinya akan otomatis terkirim ke depo farmasi. Terdapat informasi terkait resep, di antaranya adalah tanggal, nomor resep, dokter, unit (depo farmasi), status pelayanan obat, dan beberapa tombol aksi.



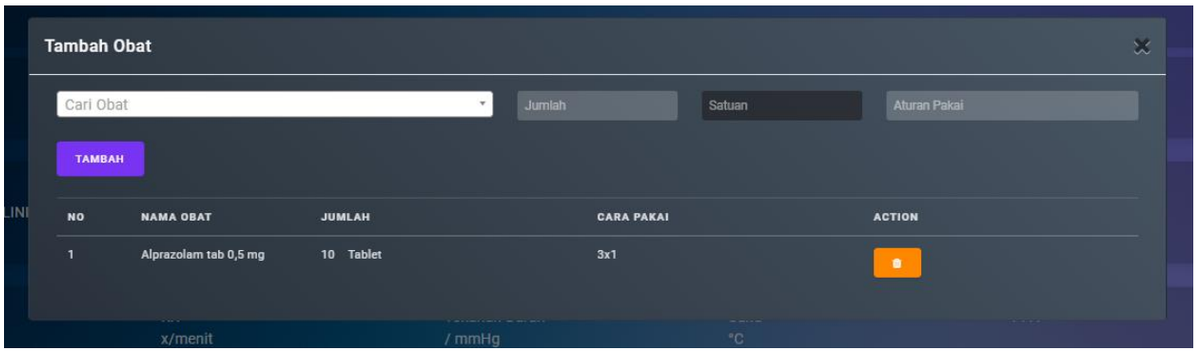
Gambar 3210. Formulir E-Resep

Untuk menambahkan obat, user mengklik tombol Tambah Obat, kemudian memilih Depo Farmasi. Setelah klik Simpan, akan muncul baris resep baru dengan status Belum Dilayani.



Gambar 33. Resep Obat yang Belum Dilayani dapat Dibatalkan atau Dihapus

Untuk menambahkan obat yang mau diberikan, user dapat klik tombol Tambah Obat di baris resep obat. User dapat mencari obat yang tersedia di depo farmasi. Jika sudah mengisi obat, jumlah dan aturan pakai, user mengklik tombol Tambah. User juga dapat menghapus obat apabila batal memasukkan obat tersebut.



Gambar 34. Input resep obat

Selama obat belum dilayani oleh Depo Farmasi, user dapat mengedit atau menghapus resep obat. User dapat klik **tombol ungu** untuk **mengedit,** dan **tombol oranye** untuk **menghapus.**

8. Petunjuk Operasional Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Dan Rekam Medis Elektronik

8.1 Buka menu komputer atau tablet internet mozila firefox atau google chrome

8.2 Akses alamat :

a. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit : http://192.168.200.4/simrs

b. Rekam Medis Elektronik : http://192.168.200.77/rme

8.3 Masukkan nama user dan password pada menu login

8.4 Username dan password setiap petugas hanya boleh digunakan oleh petugas sendiri, tidak diperbolehkan untuk didelegasikan ataupun dibagikan kepada petugas lain yang tidak berkepentingan

8.5 Pilih modul sesuai peruntukannya

8.6 Lakukan entry data secara real time, tidak boleh ada penundaan

8.7 Segala bentuk pertanjungjawaban entryan data sepenuhnya ditanggung oleh pemilik username dan password

8.8 Apabila ada kesalahan atau permasalahan data entry yang berakibat ketidaksesuaian dengan data yang dimaksud maka operator berkewajiban melaporkan kepada supervisor masing-masing / tidak boleh dilakukan perubahan atau diotak atik sendiri

8.9 Apabila supervisor tidak dapat menyelesaikan permasalahan terkait maka berkewajiban menghubungi / melaporkan ke manajer diatasnya

8.10 Apabila manajer tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut maka harus menghubungi superadmin yang telah ditetapkan dalam surat keputusan direktur ini

atau kepala instalasi admisi dan rekam medis dan kepala instalasai pengelola data elektronik

9. Penatalaksanaan Downtime Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Dan Rekam Medis Elektronik

9.1 Petugas melakukan verifikasi dengan menanyakan masalah gangguan ke WA grup SIMRS ataupun RME.

9.2 Kepala Instalasi Admisi dan Rekam Medis atau Kepala Instalasi Pengelola Data Elektronik menyampaikan klarifikasi terkait sebab gangguan, rencana tindaklanjut penyelesaian masalah dan estimasi downtime melalui WA grup SIMRS atapun RME.

9.3 Selama terjadi downtime petugas melakukan pelayanan dengan memberlakukan sistem konvensional.

9.4 Jika downtime sudah selesai, petugas harus memasukkan data yang sudah dicatat secara konvensional kedalam SIMRS ataupun RME maksimal 1x24 jam terhitung sejak downtime selesai.

RSD
dr.SOEBANDI